

Czym jest *BDD*

Dysmorficzne zaburzenie ciała (ang. body dysmorphic disorder) — uporczywe, bolesne zaabsorbowanie wyobrażoną lub przesadzoną wadą wyglądu. Nie próżność, nie kaprys. Realne zaburzenie z konkretnymi kryteriami i skuteczną terapią.

CZAS: 15 min — przeczytanie Wstęp do tematu BDD

ŹRÓDŁO: Phillips (2009); DSM-5-TR (2022); ICD-11 (2022)

JAK UŻYWAĆ

BDD — dysmorficzne zaburzenie ciała (ang. *body dysmorphic disorder*) to zaburzenie polegające na **uporczym, bolesnym zaabsorbowaniu** wyobrażoną lub przesadzoną wadą wyglądu. Osoba widzi w swoim ciele „defekt”, którego inni nie widzą — albo widzą jako drobny i nieistotny. Najczęściej dotyczy: **skóry** (trądzik, blizny, asymetria) — 73%, **włosów** (przerzedzenie, niesymetryczność) — 56%, **nosa** (kształt, rozmiar) — 37%, **masy ciała** i sylwetki — 22%, **genitaliów** — 8%. Kryteria DSM-5-TR: **1)** zaabsorbowanie wadą niewidoczną lub minimalną, **2)** powtarzane zachowania (sprawdzanie w lustrze, kamuflaż, porównywanie, pytanie o zapewnienie) lub akty mentalne (porównywanie się w myślach), **3)** klinicznie istotne cierpienie lub upośledzenie, **4)** nie jest lepiej wyjaśnione przez zaburzenie odżywiania.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Phillips (2009) w pierwszym dużym przeglądzie wykazała, że BDD **dotyczy 1,7-2,4% populacji** ogólnej — częstość porównywalna z anoreksją czy zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym (OCD). Mimo to BDD *jest często niediagnozowane*: 30–60% pacjentów nigdy nie ujawnia objawów lekarzom, bo wstyd lub obawa, że „to próżność”. Bez leczenia BDD jest **poważnym zaburzeniem**: 80% pacjentów ma myśli samobójcze, 25% próbuje samobójstwa — najwyższe wskaźniki wśród zaburzeń lękowych. Współistnieje z depresją (75%), fobią społeczną (37%), OCD (32%). *Skuteczność leczenia jest dobra*: CBT specyficzne dla BDD (Wilhelm 2013) i SSRI (fluoksetyna, escitalopram w wyższych dawkach) dają 60–80% poprawy. Pierwszy krok to **rozpoznanie** — wielu pacjentów lata cierpi w izolacji, nie wiedząc, że ma leczalne zaburzenie.

01 = Kryteria DSM-5-TR — szczegółowo

A. Zaabsorbowanie jednym lub większą liczbą wyobrażonych defektów lub wad wyglądu fizycznego, które są niewidoczne lub minimalne dla innych.

B. Powtarzane zachowania (sprawdzanie w lustrze, nadmierna pielęgnacja, skubanie skóry, poszukiwanie zapewnień) lub **powtarzane akty mentalne** (porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych) w odpowiedzi na obawy dotyczące wyglądu.

C. Zaabsorbowanie powoduje klinicznie istotne cierpienie lub upośledzenie w obszarze społecznym, zawodowym lub innym ważnym.

D. Zaabsorbowanie wyglądem nie jest lepiej wyjaśnione przez obawy dotyczące tkanki tłuszczowej lub masy ciała u osoby z zaburzeniem odżywiania.

Specyfikator: z dysmorfią mięśniową (ang. *muscle dysmorphia*) — zaabsorbowanie myślą, że ciało jest za małe lub niewystarczająco umięśnione. Częściej u mężczyzn. Czasem nazywane „bigoreksją”.

Specyfikator wglądu: dobry · słaby · brak wglądu (z urojeniami). 30–40% osób z BDD ma słaby wgląd („naprawdę tak wyglądam”) — to nadal BDD, nie psychoza.

ZWYKŁE NIEZADOWOLENIE

- Myśli o wyglądzie: kilka razy dziennie, krótko
- Można je odsunąć, gdy są inne sprawy
- Nie przeszkadza w pracy, relacjach
- Sprawdzanie w lustrze: rano, wieczorem
- Refleksja po komplementach: krótko
- Wygląd to jeden z wielu wymiarów tożsamości

BDD

- Myśli o defekcie: 3–8 godzin dziennie, intruzywne
- Niemożliwe do odsunięcia, mimo wysiłku
- Upośledzenie pracy, izolacja społeczna
- Sprawdzanie w lustrze: 30+ razy dziennie
- Niedowierzenie komplementom („*kłamie*")
- Wygląd dominuje tożsamość („*jestem tym defektem*")

✗ Sygnały, że warto skonsultować się ze specjalistą

- ☐ Myślę o swojej „wadzie” więcej niż **godzinę dziennie**, codziennie, od miesięcy
- ☐ Sprawdzam w lustrze (lub unikam luster) **kompulsywnie** — wiem, że za dużo
- ☐ Wychodzę z domu tylko po **intensywnym kamuflażu** (makijaż, ubrania, fryzura)
- ☐ Wycofuję się z pracy, szkoły, randek, spotkań z powodu wyglądu
- ☐ Kompulsywnie **pytam bliskich**, czy „*jest źle widoczne*”
- ☐ Wydaję dużo czasu i pieniędzy na zabiegi kosmetyczne, które *nie pomagają*
- ☐ Mam myśli o samobójstwie związane z wyglądem
- ☐ Bliscy mówią, że „*nie widzą tego problemu*”, ale czuję, że nie rozumieją
- ☐ Skubam skórę, włosy, paznokcie, aby „*poprawić*”
- ☐ Po komplementach wierzę, że *kłamie* lub *nie zauważył/-a*

Klucz: Phillips (2009): „*BDD jest jednym z najbardziej niedodiagnozowanych zaburzeń psychicznych. Cierpienie jest realne, ale wstyd blokuje wielu pacjentów przed szukaniem pomocy*”. Jeśli rozpoznajesz w sobie te wzorce — to **nie próżność, nie słabość, nie kaprys**. To prawdopodobnie BDD — leczalne zaburzenie z konkretnymi metodami terapii. Pierwsza wizyta u psychologa lub psychiatry znającego BDD jest *najważniejszym krokiem*. Pomoc istnieje.